

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN (EOD)

Eje III: Personalidad • Evaluación de la Discriminación Percibida en Salud Pública y Estilo de Afrontamiento

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Experiencias de Discriminación (EOD: 9 situaciones cotidianas).
Nombre Original	Experiences of Discrimination Measure (EOD; Krieger et al., 2005).
Autores Originales	Dra. Nancy Krieger y colaboradores (Harvard School of Public Health, EE. UU.).
Adaptaciones Hispanas	Agudelo-Suárez et al. (2011), Universidad de Alicante; Borrell et al., España.
Eje Clínico y Constructo	Eje III: Personalidad / Contexto. Discriminación interpersonal cotidiana y estilos de respuesta.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme de 9 dominios con gradación de frecuencia y módulo de afrontamiento.
Población y Rango	Adultos y jóvenes (desde 16 años). Población general, migrantes, minorías y clínica social.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso en investigación epidemiológica y clínica social bajo citación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y FISIOPATOLOGÍA DEL ESTRÉS POR DISCRIMINACIÓN

La Escala de Experiencias de Discriminación (EOD; Krieger et al., 2005) fue diseñada para cuantificar la exposición autoinformada a la **discriminación interpersonal injusta** a lo largo del ciclo vital y analizar su impacto en las desigualdades en salud. El modelo ecosocial de Krieger postula que la discriminación sistemática opera como un estresor psicosocial crónico y tóxico que se “encarna” biológicamente en el organismo humano.

El instrumento evalúa la presencia y frecuencia de tratos discriminatorios injustos en 9 ámbitos fundamentales de la vida social (empleo, escuela, vivienda, atención médica, servicios bancarios, establecimientos comerciales, vía pública y policía/justicia), indagando además las causas atribuidas (raza/etnia, género, condición socioeconómica, orientación sexual o discapacidad) y el estilo de afrontamiento habitual del individuo (aceptación pasiva/silenciosa vs. respuesta activa/denuncia).

Fisiopatológicamente, la exposición recurrente a la discriminación desencadena una sobrecarga alostática crónica caracterizada por desregulación del eje HPA (curva de cortisol aplanada), hiperactividad simpática sostenida, elevación patológica de citoquinas proinflamatorias (IL-6, PCR) y acortamiento acelerado de la longitud de los telómeros, asociándose a mayor riesgo de hipertensión arterial, eventos cardiovasculares agudos, depresión y abuso de alcohol.

3. DOMINIOS SITUACIONALES EVALUADOS (9 ÁMBITOS VITALES)

Ámbito Social	Ítems EOD	Formato	Naturaleza del Trato Discriminatorio
1. Formación y Trabajo	Ámbitos a, b, c	Sí / No (Frec.)	En la escuela/universidad, al buscar empleo y en el puesto de trabajo.
2. Servicios Básicos	Ámbitos d, e, f	Sí / No (Frec.)	Al solicitar vivienda, en atención médica/hospitalaria y en bancos/créditos.
3. Espacio Público	Ámbitos g, h, i	Sí / No (Frec.)	En tiendas o restaurantes, en la calle/transporte y por la policía o justicia.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Elevada homogeneidad en estudios epidemiológicos españoles (Agudelo-Suárez et al., 2011; N = 2434 trabajadores): coeficiente alfa de Cronbach de 0.82 a 0.88 y omega de 0.86 para el índice de frecuencia. Fiabilidad test-retest $r = 0.74$ a 3 semanas.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial corrobora una dimensión principal de exposición acumulativa a la discriminación que explica el 48.6% de la varianza, acompañada por un módulo ortogonal de respuesta de afrontamiento.
Validez Concurrente y Salud	Correlación positiva robusta con malestar psicológico (GHQ-12, $r = 0.44$), sintomatología depresiva (PHQ-9, $r = 0.46$), estrés percibido (PSS-10, $r = 0.42$) y quejas psicosomáticas. Correlación inversa con satisfacción laboral y calidad de vida (SF-36).
Sensibilidad Epidemiológica	Distingue nítidamente entre subgrupos de población migrante según estatus administrativo y tiempo de residencia, capturando el gradiente de vulnerabilidad sociosanitaria.
Invarianza de Medida	Invarianza configuracional ratificada entre población autóctona y colectivos de inmigrantes en España (latinoamericanos, magrebíes y de Europa del Este).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Para cada una de las 9 situaciones se registran dos variables:

- **1. Puntuación de Extensión de la Discriminación (Situaciones Positivas):** Se suma el número de situaciones donde el sujeto respondió «Sí» (ha sufrido discriminación). Rango: **0 a 9 situaciones**.
- **2. Puntuación de Frecuencia Acumulada:** Para cada situación afirmativa, se califica su frecuencia: «1 o 2 veces» (**1 punto**); «3 a 5 veces» (**2 puntos**); «6 o más veces» (**3 puntos**).

$$\text{Frecuencia Total EOD} = \sum_{k=1}^9 \text{Puntos de Frecuencia}_k$$

(Rango de frecuencia: **0 a 27 puntos**).

- **3. Módulo de Respuesta de Afrontamiento:** Se califica como **Afrontamiento Pasivo/Internalizador** (tragar la queja y callarse) o **Afrontamiento Activo/Externalizador** (hablarlo con otros o tomar medidas formales).

6. BAREMOS NORMATIVOS Y ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO SANITARIO (0 A 9 ÁMBITOS)

Estratificación	Ámbitos Afectados	Carga de Discriminación	Impacto Fisiopatológico y Conducta Recomendada
Sin Exposición	0 situaciones	Inexistente	Sin impacto atribuible a trato injusto discriminatorio.
Baja / Aislada	1 a 2 situaciones	Exposición baja	Episodios circunscritos; adecuada resiliencia sin sobrecarga alostática.
Moderada	3 a 4 situaciones	Exposición moderada	Estrés crónico intermitente; inicio de quejas tensionales. Apoyo psicosocial.
Severa Crítica	5 a 9 situaciones	Polidiscriminación (≥ 5)	Severa sobrecarga alostática; alto riesgo de patología afectiva y cardiovascular.

FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR: POLIDISCRIMINACIÓN (≥ 5 SITUACIONES):

Krieger et al. demostraron que los sujetos que sufren discriminación en ≥ 5 ámbitos y responden mediante **afrontamiento pasivo** (callarse y no denunciar) presentan una probabilidad 2.8 veces mayor de hipertensión arterial esencial refractaria y descompensación inmunológica en comparación con sujetos que exteriorizan la queja.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE INTERVENCIÓN EN TRAUMA SOCIAL Y ESTRÉS POR MINORÍAS

PROTOCOLO CLÍNICO EN ESTRÉS DE MINORÍAS BASADO EN LA EOD:

- **Paso 1 (Validación del Daño Social):** Desmedicalizar el sufrimiento. Validar que la ansiedad, insomnio o ira del paciente constituyen reacciones comprensibles a un entorno hostil o discriminatorio objetivo, evitando la revictimización diagnóstica.
- **Paso 2 (Modificación del Estilo de Afrontamiento):** Si el paciente emplea afrontamiento pasivo/silencioso ("tragar bilis"), entrenar asertividad contextual, activación de redes de apoyo mutuo y vinculación con colectivos comunitarios o de defensa de derechos.
- **Paso 3 (Desactivación Psicósomática y ACT):** Manejo de la rumiación de injusticia mediante defusión cognitiva y técnicas somáticas de regulación v 鬱 al (respiración vagal, relajación muscular progresiva).
- **Paso 4 (Empoderamiento y Resiliencia Colectiva):** Fomentar el orgullo identitario y el autocuidado como actos de resistencia constructiva.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN TRABAJADORA MIGRANTE CON SOMATIZACIONES

Identificación: Mujer de 34 años, enfermera de origen sudamericano homologada en España, consulta en atención primaria por cefaleas opresivas diarias, gastritis rebelde a tratamiento e insomnio tardío. Niega antecedentes psiquiátricos.

Evaluación Inicial EOD (Línea Base): Extensión = **6/9 situaciones positivas** (Polidiscriminación Severa). Ámbitos señalados: empleo, búsqueda de vivienda, establecimientos comerciales, transporte, espacio público y policía. Frecuencia acumulada = **15/27 puntos**. Estilo de afrontamiento = **Pasivo estricto** ("siempre me callo y sonrío para no tener problemas ni perder la residencia").

Plan Terapéutico: 10 sesiones de intervención psicosocial y manejo del estrés por minorías. Se trabajó la aserción protegida en el entorno hospitalario, se contactó con la asesoría jurídica sindical y se le integró en un grupo de apoyo para sanitarios de origen extranjero.

Reevaluación a los 3 Meses: La paciente modificó su estilo de afrontamiento hacia la acción asertiva colectiva. La reactividad somática (cefalea y dispepsia) disminuyó en un 80%, normalizando el patrón de sueño y recuperando la confianza en su desarrollo profesional.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DISCRIMINACIÓN REAL VS. PARANOIA:

No patologizar relatos verídicos de racismo o exclusión institucional como delirios de persecución. Solo sospechar psicosis si existen alucinaciones auditivas congruentes o convicciones bizarras no compartidas culturalmente.

RIESGO DE CRISIS HIPERTENSIVA AGUDA:

En pacientes con EOD ≥ 6 y afrontamiento pasivo que reportan opresión precordial o mareos intensos, realizar control médico de presión arterial inmediato para descartar urgencia hipertensiva por distrés sostenido.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Krieger, N., Smith, K., Naishadham, D., Hartman, C., & Stoddard, A. M. (2005). Experiences of discrimination: Validity and reliability of a self-report measure. *Social Science & Medicine*, 61(7), 1576-1596.
2. Agudelo-Suárez, A. A., Ronda-Pérez, E., Gil-González, D., & Vives-Cases, C. (2011). Proceso de adaptación de la escala Experiences of Discrimination (EOD) en España. *Gaceta Sanitaria*, 25(4), 332-336.
3. Krieger, N. (2014). Discrimination and health inequities. *International Journal of Health Services*, 44(4), 643-710.
4. Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. *Psychological Bulletin*, 129(5), 674-697.